

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5068051-66.2024.4.02.5101/RJ

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

**RECORRENTE:** PAULO ROBERTO CARNEIRO DA ROCHA

**RECORRIDO:** ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. SUS. CIRURGIA ORTOPÉDICA. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA. MANUTENÇÃO.

### ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 30 de outubro de 2024.

5068051-66.2024.4.02.5101

510014649813 .V3

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5068051-66.2024.4.02.5101/RJ

**RELATORA:** JUÍZA FEDERAL KARLA Nanci Grandó

**RECORRENTE:** PAULO ROBERTO CARNEIRO DA ROCHA

**RECORRIDO:** ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

**RECORRIDO:** UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

### RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Medida de Urgência interposto em face do indeferimento de tutela provisória de urgência pelo d. Juízo Federal da 23ª VF do Rio de Janeiro [evento 3, DESPADEC1, autos de origem], em que o demandante pretendia a condenação solidária das rés à realização de cirurgia ortopédica em até 72 (setenta e duas) horas ou custeio da realização na rede privada.

A tutela foi indeferida pelo juízo de origem ao seguinte fundamento:

*"Desde logo indefiro antecipação dos efeitos da tutela eis que a) trata-se de cirurgia eletiva, b) não há qualquer elemento nos autos que permita concluir que seu caso é mais grave que o dos demais usuários do SUS que se encontram à sua frente na fila."*

Em apertada síntese, o autor é portador de Transtorno dos Discos Lombares (CID 10 M51.1) e Discopatia Lombar com protusões discais (CID 10 M51.8) e desde 30/06/2021 apresenta lombociatalgia crônica, caracterizada por dor intermitente na região lombar, que se intensifica com movimentos e atividades diárias.

Conforme laudo médico do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), o tratamento empregado (fisioterapia e medicamentos) não proporcionou melhora significativa no quadro clínico do autor. Em razão disso, foi indicada, como último recurso, a realização de cirurgia, recomendada em 10/08/2022.

Em agosto de 2024, o autor recorreu à Câmara de Resolução de Litígios de Saúde (CRLS), relatando a ausência de previsão para a realização da cirurgia ortopédica desde a recomendação inicial, ocorrida dois anos antes. O autor também informou que continua a sofrer de dores intensas, mesmo com o uso de medicamentos paliativos, incluindo opióides.

De acordo com Parecer Técnico CRLS Nº 106975/2024, o Sistema Estadual de Regulação (SER) registra o autor na posição 186 na fila para o procedimento cirúrgico, na sub-fila para "doença degenerativa lombar - artrotese", a ser realizado pelo INTO.

Aduz a **probabilidade do direito** através da documentação anexa aos autos, notadamente documentos médicos exarados por profissionais vinculados ao SUS e parecer da CRLS, em que se comprova a existência da patologia, a indispensabilidade do atendimento de saúde pleiteado e a demora do Poder Público para o atendimento, já em violação ao Enunciado 93 do CNJ.

Ademais, o **perigo na demora** do provimento jurisdicional se justificaria porque *"autor espera, desde agosto de 2022, para a realização da Cirurgia Ortopédica, de forma que o longo tempo de espera implica risco imediato de agravamento do quadro clínico do ora Recorrente, como também de limitações funcionais incapacitantes e afastamento da atividade laboral"*.

Tutela recursal indeferida [evento 7, DESPADEC1].

Sem contrarrazões pelas recorridas, em que pese regularmente intimadas.

Parecer técnico do NATJUS [evento 18, PARECER1].

É o breve relatório. Decido.

## VOTO

A questão não suscita maior complexidade, porquanto enfrentada pela decisão monocrática que indeferiu a liminar, cujas razões reproduzo em verdadeira hipótese de fundamentação *aliunde* ou *per relationem*:

*"Em linha de princípio, importante destacar que o Enunciado nº 93 da III Jornada de Saúde do CNJ firmou o entendimento segundo o qual considera excessiva a demora no acesso à serviços de saúde nas seguintes hipóteses:*

*"Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo **superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.**"*

*Portanto, interpreta-se que o CNJ definiu parâmetros objetivos os quais, ultrapassados, configuram excessividade na demora em obter serviços eletivos de saúde no âmbito do SUS.*

*Isso pontuado, a controvérsia recursal, tratando-se de recurso de medida cautelar e diante do indeferimento da tutela de urgência na origem, reside em analisar a presença, ou não, dos requisitos do art. 300 do CPC nos autos, ou seja, a probabilidade do direito vindicado, perigo de dano ou o risco para o resultado útil do processo, ensejadores, ou não, da manutenção da decisão impugnada com base no conjunto fático-probatório presente.*

*Assim colocado, como será visto ao final, a análise do quadro clínico não evidencia perigo de morte a justificar intervenção judicial in casu. A despeito do quadro clínico denotar-se delicado, constata-se a ausência de demonstração inequívoca e cumulativa dos requisitos para a concessão de medida antecipatória nos termos do art. 300 do CPC.*

*Pois bem. O quadro de saúde motivador do pedido de antecipação de tutela recursal consta na documentação médica anexa nos autos originários [evento 1, ANEXO2, fl. 13-20], cuja interpretação dada é no sentido do indeferimento da tutela de urgência pretendida tal como se encontra.*

*Assim se afigura na medida em que, nos autos, o perigo de dano não resta demonstrado em laudo médico circunstanciado no sentido de urgência e perigo imediato de óbito. Na verdade, é informado que o caso é intratável, que existe o uso de medicamento para analgesia das dores pelo demandante e a situação de espera na convocação para cirurgia no SUS sem citar risco de óbito ou perda irreversível de função ensejadora de prioridade no atendimento cirúrgico [evento 1, ANEXO2, fl. 14]:*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>PACIENTE 57 ANOS, PORTADOR DE HAS, APRESENTA DOR LOMBAR INTENSA DEVIDO A DISCOPATIA. RM DE COLUMA LOMBAR APRESENTA ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NOS PLATÔS DE L2 E S1, ARTROSE INTERFACETÁRIA L5-S1, DESIDRTAÇÃO DISCAL E REDUÇÃO DA ALTURA DE L2-L3 E L5-S1.</p> <p>ABAUAMENTO DISCAL DIFUSO CONTACTANDO SACO DURAL E REDUZINDO A AMPLITUDE DO CANAL, PROMOVENDO COMPRESSÃO SOBRE A FACE VENTRAL SOBRE A RAÍZ NERVOUSA DESCENDENTE DE S1 À ESQUERDA.</p> <p>JÁ REALIZOU TRATAMENTO CONSERVADOR COM FISIOTERAPIA E TRATAMENTO <b>MEDICAMENTOSO MAS SEM MELHORA</b></p> <p>EFETIVA. DA DOR. ESTÁ EM TRATAMENTO ABORTIVO PARA DOR, COM NECESSIDD DE <b>OPIÓIDES PARA ANALGESIA EFICAZ</b>. O PACIENTE AGUARDA REALIZAÇÃO DE INTERVENÇÃO CIRURGICA (ARTRODESE DE COLUMA) PELO INSTITUTO NACIONAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA (INTO)</p> <p>O PACIENTE <b>JÁ FOI AVALIADO PELO SERVIÇO</b>, ONDE HOVE VERIFICAÇÃO DA <b>INTRATABILIDADE CLINICA</b> DE SEU QUÁDRO E AGORA <b>AGUARDA SER CONVOCADO</b></p> |
| <p>RIO DE JANEIRO, 22 de Maio de 2024</p> <p>_____<br/>Michele F. Gonçalves<br/>Assinatura e Carimbo do Profissional<br/>(Dr(a) MICHELE LINHARES GONCALVES<br/>Médico da estratégia de saúde da família</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Nesse contexto, a despeito do pleito estar indicado e atestada a demora no consequimento na via administrativa conforme o parecer técnico da Câmara de Resolução de Litígios em Saúde - CRLS no [evento 1, ANEXO2, fls. 21-23], como dito, não se vislumbra perigo na demora e risco ao resultado útil do processo dada a falta de repercussões de saúde irreparáveis ou morte do demandante, o que vislumbra a viabilidade no consequimento do pleito ainda que não em sede de antecipação de tutela recursal.

Registre-se: de modo algum se pode relativizar o quadro, mas o que se verifica, in casu, é mais uma situação aflitiva no campo da Saúde Pública, sobretudo sob a ótica e os efeitos concretos para o paciente e seus familiares. No entanto, não se revela desamparo e risco iminente de morte, de maneira a justificar a excepcionalidade da alteração abrupta da ordem de prioridade, segundo o regramento atinente ao Sistema Estadual de Regulação - SER, o qual se destina a assegurar isonomia no tocante à inevitável observação de fila de espera nos hospitais públicos.

Ainda que fosse o caso, dito de outro modo, não se está a dizer que a excepcionalidade não é constitucionalmente viável, mas desde que na presença de evidência fático-jurídico-constitucional que lhe dê efetivamente respaldo. E, tal como se encontra o feito, a pretensão não reúne os elementos preconizados, por exemplo, no Enunciado nº 51 oriundo da II Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

*"51 - Saúde Pública - Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato."*

Portanto, a despeito das razões oferecidas pelo demandante, diante do conjunto fático-probatório tal como se encontra, elas cedem diante da ausência de demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, razão pela qual a solução dada na decisão do juízo anterior merece ser mantida.

Nesse sentido, desta 6ª Turma Recursal, com os ajustes necessários, o julgamento, por unanimidade, do processo nº 5007668-90.2022.4.02.5102 na Sessão Extraordinária de 05/07/2023:

**"RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SUS. CIRURGIA. CRONOLOGIA DO SISTEMA ESTADUAL DE REGULAÇÃO. NECESSIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA."**

Ademais, também desta Turma Recursal e especificamente quanto ao Enunciado nº 93 do CNJ, relatoria da Juíza Federal Dra. ALESSANDRA BELFORT BUENO, o julgamento colegiado no processo nº 5032726-30.2024.4.02.5101 na Sessão Extraordinária de 19/06/2024. Agora reproduzido o teor do voto e a ementa do acórdão:

**"[...] Analisando os fatos narrados e os documentos apresentados, verifico que, apesar da espera até então enfrentada, para além do considerado razoável pelo enunciado 93, a tutela de urgência pretendida, consistente na marcação do exame de audiometria para auxiliar no diagnóstico do quadro clínico de perda da auditiva, de caráter satisfativo, sem a oitiva da parte contrária, pode implicar em violação à isonomia em relação as demais pessoas que também aguardam o agendamento desse mesmo exame."**

Ademais, tendo em conta o rito célere dos Juizados Especiais Federais, não vislumbro, em juízo de prelibação, risco no resultado útil do processo.

Portanto, nesse momento, entendo ausentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada inaudita altera pars, na forma do art. 300 do CPC, necessitando a demanda de maior instrução probatória, ressalvada, porém, a reapreciação do pedido antecipatório da tutela, após a manifestação do NAT e por ocasião do julgamento desta medida de urgência. [...]"

**"MEDIDA DE URGÊNCIA. EXAME DE AUDIOMETRIA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. RAZÕES RECURSAIS INAPTAS A AFASTAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MEDIDA DE URGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA."**

Ademais, importante realizar distinguishing com o precedente da 8ª Turma Recursal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região - TRF2 no julgamento colegiado do processo nº 5110408-66.2021.4.02.5101, relatoria da Juíza Federal Dra. DANIELLA ROCHA SANTOS FERREIRA DE SOUZA MOTTA, na Sessão Extraordinária de 30/11/2021, assim ementado:

**"MEDIDA DE URGÊNCIA. SAÚDE. IDOSO. AVALIAÇÃO CIRURGIA E ACOMPANHAMENTO EM ORTOPEDIA. FRATURA DE OMBRO. INSERIDA NO SER DESDE 05/05/2021. RISCO DE LIMITAÇÃO DEFINITIVA DE MOVIMENTO DOS OMBROS SE PROCEDIMENTO NÃO FOR REALIZADO NO PRAZO DE 7 DIAS, CONFORME LAUDO MÉDICO. TUTELA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO O AGENDAMENTO DE CONSULTA NO PRAZO DE 72 HORAS. CONSULTA AGENDADA PARA 26/10/2021 NO INTO. SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO INFORMA QUE A AUTORA OCUPA A POSIÇÃO DE N.º 2.059 NA FILA DE UM TOTAL DE 3.256 PACIENTES. ENUNCIADO 93 DO CNJ. EXCESSIVO PRAZO SUPERIOR A 100 DIAS PARA CONSULTAS E EXAMES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO."**

Como visto, na ocasião do julgamento da medida cautelar com natureza de agravo de instrumento interposto pela União foi negado o provimento ao recurso e confirmada a decisão monocrática no sentido de que a intervenção judicial, naquele caso, se justifica no risco de limitação definitiva de movimento dos ombros sem a cirurgia em pequeno lapso temporal, conforme indicado em relato médico nos autos. Nesse rumo, além de devidamente comprovada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a excessividade da demora foi evidenciada conforme definiu o CNJ no Enunciado nº 93.

Nesse cenário, em juízo de prelibação, a decisão impugnada apresenta-se, além de seu conteúdo fático-probatante próprio, em conformidade com as diretrizes do Conselho Nacional de Justiça - CNJ relativamente às questões de Direito da Saúde, e com múltiplos julgados desta 6ª Turma Recursal em situações análogas e reiteradas, consoante se extrai, v.g., dos Enunciados a seguir reproduzidos:

*Enunciado nº 18. "Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - Natjus e/ou consulta do banco de dados pertinente." (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)*

*Enunciado nº 19. "As iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde - 18.03.2019)"*

*Portanto, sem que se cuide de julgamento de mérito propriamente dito, que enseja o amadurecimento da causa e a demonstração de urgência e necessidade na fase de instrução, **desacolho** o pleito de atribuição de efeito suspensivo ativo."*

Nada obstante, é de se registrar que o parecer técnico do NATJUS [evento 18, PARECER1] somente foi anexado aos autos em 02/10/2024, portanto após a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal. Seu conteúdo, todavia, não traz elementos capazes de infirmar o indeferimento.

Em absoluta coincidência com o parecer da CRLS [evento 1, ANEXO3, fls. 21/23] o parecer do NATJUS [evento 18, PARECER1] reconhece que a cirurgia ortopédica é indicada no caso, está coberta pelo SUS e que a via administrativa já foi utilizada, sem a resolução da demanda.

A despeito da ampla documentação confirmatória da indicação do tratamento e da caracterização da demora excessiva na prestação do serviço pelo SUS, consoante disposições dos Enunciados 51 e 95 das II e III Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, respectivamente, não vislumbro violação de direitos fundamentais, nem conduta ilegal ou abusiva do Poder Público que justifique a atuação do Poder Judiciário.

Ademais, **não há nos autos comprovação de iminente risco de dano irreversível** que justifique, excepcionalmente, a quebra do procedimento organizacional adotado na esfera administrativa. Destaco, neste sentido, que a documentação anexa ao feito informa que o caso é intratável, exige o uso de medicamento para analgesia das dores, mas não cita risco de óbito ou perda irreversível de função motora [evento 1, ANEXO2, fl. 14].

Isto posto, entendo que a causa exige autocontenção pelo Poder Judiciário, conforme jurisprudência a seguir colacionada, que vê na fila do SUS critério objetivo de isonomia para casos análogos:

**AGRAVO INTERNO. LIMINAR. CIRURGIA. FILA. ORDEM DE INSCRIÇÃO. OBEDIÊNCIA. ISONOMIA.** 1. A despeito da generosa interpretação dada ao art. 196 da Constituição por alguns arestos, certo é que o Estado não tem condições de assegurar, a todos e de pronto, 'o acesso ao tratamento necessário a cura de suas doenças', principalmente nos poucos hospitais públicos de referência existentes no País. 2. **Sem demonstração de ilegitimidade da fila e, pois, da ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, LXIX, CF), qualquer decisão judicial que determine cirurgia imediata caracterizaria injustificada vantagem pessoal a vista da situação comum em que se encontram os vários pacientes na fila, eis que "descabe ao Judiciário estabelecer prioridades de natureza médica.** Este não é administrador do SUS e, caso se admitisse a sua intervenção indevida, teria também que resolver os problemas decorrentes de sua atuação, haja vista que se uma pessoa realiza o exame por força de tutela judicial, outra, que teria direito por ordem natural, seria prejudicada" (cf. TRF2, 7ª Turma Esp., AI no 2010.02.01.017554-5, Rel. Des. Fed. Jose Antonio Lisboa Neiva). 3. Assim, embora lamentando profundamente a situação, não cabe ao Judiciário quebrar a isonomia. 4. Agravo interno desprovido

(TRF-2, AI 217227, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo da Silva Araújo Filho, j. 10/10/2012).

**CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO À SAÚDE. ART. 196, CF. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL DA REDE PÚBLICA. ISONOMIA. RESPEITO À FILA ADMINISTRATIVAMENTE ORGANIZADA.** 1. O direito à saúde implica para o Poder Público o dever inescusável de adotar providências necessárias e indispensáveis para a sua promoção, estabelecidas de forma universal e igualitária. Nesse contexto jurídico, se o Poder Público negligencia no atendimento de seu dever, cumpre ao Poder Judiciário intervir, num verdadeiro controle judicial de política pública, para conferir efetividade ao correspondente preceito constitucional. 2. **Todavia, o acesso ao referido direito deve ser compatibilizado com o princípio da isonomia, de forma a não garantir privilégios àqueles que procuram o Judiciário em detrimento dos que aguardam por tratamentos e cirurgias de acordo com a fila administrativamente estabelecida. Assim, não cabe ao Judiciário administrar hospitais, estabelecendo prioridades de natureza médica. Precedentes.** 3. Dessa forma, cabe à Administração Pública, mediante exame com base em critérios técnicos, aferir a possibilidade de internação no INCA ou em qualquer outro hospital da rede pública, respeitando a fila administrativamente estabelecida. 4. Por outro lado, é inviável, em um quadro insatisfatório,

*socializar o custeio de internação em rede hospitalar privada. Do mais, o deferimento do pedido, nesta hipótese, também representaria verdadeira preterição aos pacientes que aguardam na fila de espera. 5. Embargos infringentes conhecidos e providos.*

*(EAC 201151014901233 Desembargador Federal JOSE ANTONIO LISBOA NEIVA TERCEIRA SEÇÃO ESPECIALIZADA -DJF2R - Data::02/10/2012 - Página::28/29)*

Merece confirmação a decisão monocrática de indeferimento da tutela recursal e, no mérito, merece desprovimento o recurso, para manter a decisão recorrida.

Nessas condições, **VOTO por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Intimem-se.** Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Publique-se. Intimem-se. Decorrido prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos à origem. Transcorrido o prazo, dê-se baixa e encaminhe-se ao Juízo de Origem.